



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شاديه محمد محمد فرج الله
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 27703201201902 رقم التليفون : 01152424733
العمر (تاريخ الميلاد) : 20-03-1977 المهنة : ربه منزل
العنوان : المشروع الأمريكى
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : ورم خبيث بالمستقيم

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : ورم خبيث بالمستقيم

خطة العلاج : أورام كيماوي خط علاج كيميائي مابعد الجراحه طبقا لبروتوكول (Capecitabine) من 8 جرعات (قرار واحد فقط) شامل التحاليل والعلاج الدوائي المصاحب للجرعه [14235]
قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شاديه محمد محمد فرج الله National ID: 27703201201902	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of colorectal cancer for Capecitabine chemotherapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٣/٠٢ ٢٧٧٠٣٢٠١٢٠١٩٠٢
حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية
أنشئ منظمة متروحة
اشرف جوده عبد الحفيظ المحلل
المنطقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٢/٢٦



شهادة كفاءة
مطابقة تحقيق الشخصية

شليليه
محمد محمد فرج الله الزعلاوي
مجاورة رقم ٨١١ - المشروع الأمريكي
حقوق - القاهرة



٢٧٧٠٣٢٠١٢٠١٩٠٢

JM3617004

Date Of Submission:

Date Of MDT: 06/28/2026 10:35:06



General GRI-E MDT form

Patient Name :	شادية محمد محمد فرج الله	Age :	49 Y
Sex :	☐ Male ☐ Female	Comorbidity :	
ID No. :	10514	Telephone :	01152424733
Family History :	27703201201902	Marital Status :	☐ Married ☐ Divorced ☐ Single
Menopausal Status :		Reason of MDT :	
Menopausal Status :	MDT	MDT name::	

Medical Report

Diagnosis :	
Notes :	
History:	49 yo female, no DM, HTN , Cardiac. Positive Family history (Mother HCC). diagnosed with Rectal adenocarcinoma by Colonoscopic biopsy only (7cm from anal verge) HPE invasive adenoca MRI pelvis 13/6/26 high and mid rectal circumferential mural thickening extraserosal extention with positive CRM WITH OBLITERATION OF FAT PLANES (peritoneal invasion M1C)
Investigations:	
Recommendations:	FOR TNT
MDT DECISION:	CHECK for ct abd start FOLFIRINOX 2 ms then reevaluation and re MDT for possibility of concurrent cth /rth then surgeryu

Signature

Hematology

Pediatric

Bone marrow transplant

د / حنان عزت

د / احمد نجيب

Patient Name	: الأستاذ / شادية محمد محمد فرج الله	Request No.	: 13006169
Patient No.	: 27703201201902	Request Date	: 28/04/2026
Path No.	: SR-513/26	Verification Date	: 12/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوماتف رومسي - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Colonoscope showing rectal mass 7 cm from anal verge.
Nature of specimen: Referred block & slide (Colonoscopic biopsy).

Gross Examination:
One referred block & one referred (H&E) stained slide labelled by (26010679) & patient name.

Microscopic examination:
- Histopathological examination reveals pieces of colonic mucosa showing tumor formed of distorted glands with fused & cribriform forms lined by malignant columnar epithelial with moderate nuclear plomorphism & hyperchromasia amid desmoplastic stroma.

Diagnosis:
Rectal mass, Referred block & slide (Colonoscopic biopsy):
- Invasive adenocarcinoma, Grade 2.

Signature:
Dr. Walaa Ibrahem Ghoneim.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 24/05/2026 09:17:52

Page 1 of 1

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذ / شاديه محمد محمد فرج الله	Request No.	: 13006169
Patient No.	: 27703201201902	Request Date	: 28/04/2026
Path No.	: SR-513/26	Verification Date	: 12/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 49 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Colonoscope showing rectal mass 7 cm from anal verge.
Nature of specimen: Referred block & slide (Colonoscopic biopsy).

Gross Examination:

One referred block & one referred (H&E) stained slide labelled by (26010679) & patient name.

Microscopic examination:

- Histopathological examination reveals pieces of colonic mucosa showing tumor formed of distorted glands with fused & cribriform forms lined by malignant columnar epithelial with moderate nuclear pleomorphism & hyperchromasia amid desmoplastic stroma.

Diagnosis:

Rectal mass, Referred block & slide (Colonoscopic biopsy):
- Invasive adenocarcinoma, Grade 2.

Signature:

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 24/05/2026 09:17:52

Page 1 of 1

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

MRI OF THE PELVIS WITH CONTRAST

Technique: Axial T1, T2, STIR & DWI - Coronal T1, T2 & STIR WI - Sagittal T2 WI - Post-contrast images

Findings:

A reported case of rectal adenocarcinoma:

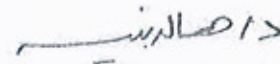
- High and Mid rectal circumferential polypoidal irregular mural thickening, extra-serosal extension with positive CRM (one of the pathologically enlarged lymph nodes noted closely related to meso-rectal fascia) as follows:
 - Length of involvement: around 6 cm.
 - Lower end of the tumor to the anal verge: 9.5 cm
 - about 4 cm from anorectal junction.
 - Maximum thickness: 16 mm
 - Associated smudging of the mesenteric fat with enlarged lymph nodes (largest is rounded, measures about 13 mm). (Stage N2b)
 - Indistinct borders of muscularis propria, with extramural invasion, about 1- 5 mm. (Stage T3b).
 - Obliteration of fat planes, between posterior uterine peritoneal reflections and the anterior rectal wall? peritoneal invasion. (Stage M1c).
- Inadequately distended urinary bladder. No gross masses or calculi filling defects.
- Unremarkable MRI appearance of the uterus and both ovaries.

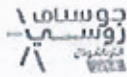
Opinion: Neoplastic process centered to the Mid and high rectum, with the above listed associations. (Likely stage IV).

Dr. Takwa Mostafa

Dr. Aya Mohamed

Dr. Ali El Saied, MD, EFR, EBIR





Patient's Name: Shadia Mohammed
Date: 2026-06-06
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST WITHOUT

CONTRAST REVEALED:-

- No pulmonary nodules, masses, consolidation, collapse or cavitary lesions.
- Left lingular atelectatic band.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- Prominent bilateral axillary lymph nodes.
- No pleural or pericardial effusion.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Intact bony thoracic cage.

Opinion:-

- ❖ No metastatic pulmonary lesions.

Dr.sherif Wagdy



Patient Name: SHADYA MOHAMED MOHAMED 49Y	Patient ID: 27703201201902
Age: 49 Years, 5 Months, 12 Days	Study Date: 13/06/2026 01:04:38 PM

DYNAMIC MRI STUDY OF THE ABDOMEN

Technique of Examination:

- Axial T1 { in-out phases }, T2 & T2 fat sat, DWI & ADC.
- Coronal T2.
- Multiple Axial post contrast T1 series.

MRI Findings:

****A reported case of rectal adenocarcinoma.**

- Average size of the liver showing smooth outline. No pathologically enhancing focal hepatic lesions.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicle dilatation.
- Gall bladder is of average distension with no evidence of filling defects or masses inside. CBD is not dilated.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches.
- Normal size & MR signal of the spleen, with no focal lesions within its parenchyma.
- Normal site, size, parenchymal thickness & excretory function of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- No ascites.
- No pathologically enlarged pelvi-abdominal lymph nodes.
- Normal MRI appearance of the lung bases.

Opinion:

- No pathologically enhancing focal hepatic lesions.
- Unremarkable MRI study of the abdomen.

MRI OF THE PELVIS WITH CONTRAST

Technique: Axial T1, T2, STIR & DWI - Coronal T1, T2 & STIR WI - Sagittal T2 WI - Post-contrast images

Findings:

A reported case of rectal adenocarcinoma:

- High and Mid rectal circumferential polypoidal irregular mural thickening, extra-serosal extension with positive CRM (one of the pathologically enlarged lymph nodes noted closely related to meso-rectal fascia) as follows:
 - Length of involvement: around 6 cm.
 - Lower end of the tumor to the anal verge: 9.5 cm
 - about 4 cm from anorectal junction.
 - Maximum thickness: 16 mm
 - Associated smudging of the mesenteric fat with enlarged lymph nodes (largest is rounded, measures about 13 mm). (Stage N2b)
 - Indistinct borders of muscularis propria, with extramural invasion, about 1- 5 mm. (Stage T3b).
 - Obliteration of fat planes, between posterior uterine peritoneal reflections and the anterior rectal wall? peritoneal invasion. (Stage M1c).
- Inadequately distended urinary bladder. No gross masses or calculi filling defects.
- Unremarkable MRI appearance of the uterus and both ovaries.

Opinion: Neoplastic process centered to the Mid and high rectum, with the above listed associations. (Likely stage IV).

Dr. Takwa Mostafa

Dr. Aya Mohamed

Dr. Ali El Saied, MD, EFR, EBIR

13/5/2023

patient's name: Shadia Mohammed Mohammed Farag Allah
Date: 2026-08-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Rousey International Egypt

OPEN MR EXAMINATION OF THE BRAIN

TECHNIQUE:

Axial T1, T2, FLAIR, diffusion & ADC WIs

Coronal T2 WIs

Sagittal T1 WIs

No contrast was given

FINDINGS:

- Normal size and configuration of the ventricular system.
- No midline shift or deformity.
- No evidence of cerebral, cerebellar or brain stem areas of abnormal signal.
- Normal cortical sulci and extra axial CSF spaces.
- No evidence of extra axial collections.
- No cerebello pontine angle masses.
- No evidence of posterior fossa abnormalities.
- Intact cervico medullary junction.

OPINION:

Normal MRI of the brain.



Much Obliged;
Dr.Marwa Elgawish, MSc, FEBR

patient's name: Shadia Mohammed Mohammed Farag Allah
Date: 2026-08-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Rousey International Egypt

OPEN MR EXAMINATION OF THE BRAIN

TECHNIQUE:

Axial T1, T2, FLAIR, diffusion & ADC WIs

Coronal T2 WIs

Sagittal T1 WIs

No contrast was given

FINDINGS:

- Normal size and configuration of the ventricular system.
- No midline shift or deformity.
- No evidence of cerebral, cerebellar or brain stem areas of abnormal signal.
- Normal cortical sulci and extra axial CSF spaces.
- No evidence of extra axial collections.
- No cerebello pontine angle masses.
- No evidence of posterior fossa abnormalities.
- Intact cervico medullary junction.

OPINION:

Normal MRI of the brain.



Much Obliged;
Dr.Marwa Elgawish, MSc, FEBR